

Handicap, autonomie et travail social

Cours intensif en 8 séances de 2 heures — version condensée du module Bachelor TS

Pierre Brasseur · HETS Genève · HES-SO

2026-06-05

Table des matières

COURS INTENSIF — 8 SÉANCES DE 2 HEURES	2
Présentation du dispositif	2
SÉANCE 1 — HISTOIRES ET GRAMMAIRES DU HANDICAP	3
Objectifs	3
Plan minuté (2 h)	4
Cadre théorique	4
Lectures préparatoires (jigsaw)	4
Bibliographie complète de la séance	5
Travail attendu pour la séance 2	5
SÉANCE 2 — MODÈLE SOCIAL ET DISABILITY STUDIES	6
Objectifs	6
Plan minuté (2 h)	6
Cadre théorique	6
Lectures préparatoires (jigsaw)	7
Bibliographie complète de la séance	7
Travail attendu pour la séance 3	8
SÉANCE 3 — MODÈLES FRANCOPHONES : MDH-PPH ET CAPABILITÉS	8
Objectifs	8
Plan minuté (2 h)	8
Cadre théorique	8
Lectures préparatoires (jigsaw)	10
Bibliographie complète de la séance	10
Travail attendu pour la séance 4	11
SÉANCE 4 — DÉINSTITUTIONNALISATION	11
Objectifs	11
Plan minuté (2 h)	11
Cadre théorique	11
Lectures préparatoires (jigsaw)	12
Bibliographie complète de la séance	13
Travail attendu pour la séance 5	13
SÉANCE 5 — AUTODÉTERMINATION ET PAIR-AIDANCE	13
Objectifs	13
Plan minuté (2 h)	14
Cadre théorique	14
Lectures préparatoires (jigsaw)	15
Bibliographie complète de la séance	15

Travail attendu pour la séance 6	16
SÉANCE 6 – FINANCEMENT ORIENTÉ PERSONNE	16
Objectifs	16
Plan minuté (2 h)	16
Cadre théorique	17
Lectures préparatoires (jigsaw)	18
Bibliographie complète de la séance	18
Travail attendu pour la séance 7	18
SÉANCE 7 – POSTURE PROFESSIONNELLE : TROIS TENSIONS	18
Objectifs	18
Plan minuté (2 h)	19
Cadre théorique	19
Lectures préparatoires (jigsaw)	20
Bibliographie complète de la séance	21
Travail attendu pour la séance 8	21
SÉANCE 8 – APPLICATION ET PERSPECTIVES	21
Objectifs	21
Plan minuté (2 h)	21
Cadre théorique	22
Lectures préparatoires (jigsaw)	23
Bibliographie complète de la séance	23
Travail final (rendu 4 semaines après la séance 8)	23
RESSOURCES TRANSVERSALES	24
Bibliographie générale (à disposition tout au long du cours)	24
Ressources institutionnelles genevoises	24
Cadre éthique du cours	24
Articulation avec les autres dispositifs HETS	24

COURS INTENSIF – 8 SÉANCES DE 2 HEURES

Présentation du dispositif

Identité

Élément	Valeur
Intitulé	Handicap, autonomie et travail social
Format	Cours intensif Bachelor TS (variante du module 13 séances) ou MAP de spécialisation
Volume	8 séances × 2 h = 16 h présentiel + 32 h travail personnel
ECTS	2 ECTS
Public	Bachelor TS semestre 4-6, MAP de spécialisation 5-6, ou formation continue
Effectif	18-30 étudiant-es

Compétences PEC20 ciblées

C1 (mission), C2 (éthique/politique), C3 (analyse), C4 (projets), C5 (ressources), C7 (théories), C8 (réflexivité), C9 (coopération), C11 (évaluation).

Architecture pédagogique

Le cours suit une progression **diagnostic** □ **cartographie** □ **application**.

Séance	Mouvement	Question structurante
1	Diagnostic historique	Comment en sommes-nous arrivés là ?
2-3	Cartographie théorique	Quels modèles disponibles pour penser le handicap ?
4-6	Cartographie politique	Quelles transformations contemporaines ?
7	Cartographie professionnelle	Quelles tensions structurelles de posture ?
8	Application	Que faire en formation pratique ?

Méthode pédagogique

Chaque séance combine **trois temps** :

1. **Exposé cadré** (45 min) — l'enseignant pose les concepts, les controverses, les jalons
2. **Travail en sous-groupes sur lectures préparatoires** (45 min) — *jigsaw* : 3-4 lectures distribuées en amont, chaque sous-groupe restitue à plénière
3. **Synthèse + ouverture** (30 min) — articulation, ouverture, lecture pour la séance suivante

Modalités d'évaluation

Modalité	Pondération	Échéance
Participation aux jigsaws (1 restitution par étudiant-e minimum)	20 %	Continu
Carnet de bord (3 entrées d'1 page chacune, sur 3 séances au choix)	30 %	Continu
Travail final : analyse d'une situation de FP avec mobilisation d'au moins 8 références du cours (12 pages)	50 %	4 semaines après séance 8

Articulation avec la formation pratique

Dès la séance 1, chaque étudiant-e identifie un **cas-fil** issu de sa FP. Le cas est mobilisé dans le carnet de bord et dans le travail final.

SÉANCE 1 — HISTOIRES ET GRAMMAIRES DU HANDICAP

Objectifs

À l'issue de la séance, l'étudiant-e sera capable de :

1. Distinguer **handicap comme catégorie construite** et handicap comme expérience corporelle
2. Identifier les **figures historiques** successives de la personne handicapée (protégé, déficient, inadapté, sujet de droits)
3. Reconnaître la **dimension politique** des catégorisations administratives

Plan minuté (2 h)

Temps	Contenu	Activité
0-10 min	Introduction au cours, contrat pédagogique, vignette de Léa	Exposé
10-30 min	Anthropologie historique du handicap : la modernité comme paradigme de la réadaptation	Exposé + slides
30-50 min	Sociologie du stigmat : Goffman, discrédité/discréditable, <i>passing</i>	Exposé + discussion
50-65 min	Sociologie du handicap comme catégorie d'action publique : construction sociale, normalisation, controverses	Exposé
65-110 min	Jigsaw : 4 sous-groupes travaillent chacun un texte. Restitution croisée.	Travail collectif
110-120 min	Synthèse + introduction séance 2	Discussion

Cadre théorique

La modernité comme paradigme de la réadaptation

Henri-Jacques Stiker (*Corps infirmes et sociétés*, 1982/2013) propose une anthropologie historique. Chaque société construit un rapport spécifique à l'infirmité. La modernité produit le paradigme de la **réadaptation** : ramener à la norme, à l'identique. Le paradoxe : « *Réadapter, c'est ramener à la norme, à l'identique, et c'est par là même désigner comme différent* ».

Le stigmat comme processus relationnel

Erving Goffman (*Stigmat*, 1963/1975) analyse le stigmat comme un **attribut socialement disqualifiant** qui transforme dans l'interaction une personne « normale » en personne « entachée ». Trois types : corporel, de caractère, tribal. Trois positions sociales : normaux, stigmatisés, *initiés/sages*.

Concepts opérationnels pour le TS :

- **Discrédité** (le stigmat est visible) vs **discréditable** (il peut être dissimulé)
- **Passing** — dissimuler son stigmat dans l'interaction (coût identitaire élevé)
- **Covering** — minimiser l'impact d'un stigmat qu'on ne peut cacher

Le handicap comme catégorie d'action publique

Isabelle Ville, Emmanuelle Fillion et Jean-François Ravaud (*Introduction à la sociologie du handicap*, 2014/2020) synthétisent un demi-siècle de sociologie : le handicap n'est pas un donné mais un construit historique, social et politique. La catégorisation administrative (l'AI, la MDPH, le taux d'invalidité) **produit** ce qu'elle prétend décrire.

Lectures préparatoires (jigsaw)

Chaque sous-groupe lit **un seul** texte avant la séance et restitue à plénière.

Groupe A — Stiker

Stiker, H.-J. (2013). *Corps infirmes et sociétés*. Dunod. **Chapitre III** (la réadaptation comme paradigme moderne, 30 pages).

Questions guides :

- Qu'est-ce que le paradigme de la réadaptation selon Stiker ?
- Pourquoi ce paradigme « désigne comme différent » ce qu'il prétend normaliser ?
- Quel exemple contemporain illustre ce paradoxe ?

Groupe B — Goffman

Goffman, E. (1975). *Stigmate*. Minuit. **Introduction et chapitre 1** (40 pages).

Questions guides :

- Quelle est la définition goffmanienne du stigmate ?
- Quelle distinction entre discrédité et discréditable ?
- Quelles conséquences pour la posture du TS face à un usager qui « cache » sa situation administrative ?

Groupe C — Ville-Fillion-Ravaud

Ville, Fillion & Ravaud (2020). *Introduction à la sociologie du handicap*. De Boeck. **Chapitre 1** (« Définir le handicap », 25 pages).

Questions guides :

- Pourquoi les définitions du handicap varient-elles selon les époques et les contextes administratifs ?
- Comment la catégorisation administrative « produit » du handicap ?
- Quels effets sur les pratiques professionnelles ?

Groupe D — Revillard

Revillard, A. (2020). *Des droits vulnérables*. Presses de Sciences Po. **Introduction et chapitre 1** (40 pages).

Questions guides :

- Que désigne le concept de « droits vulnérables » ?
- Quelle distinction entre droit proclamé et droit effectif ?
- Comment le TS contribue-t-il à l'effectivité des droits ?

Bibliographie complète de la séance

Goffman, E. (1963/1975). *Stigmate. Les usages sociaux des handicaps*. Paris : Minuit.

Revillard, A. (2020). *Des droits vulnérables. Handicap, action publique et changement social*. Paris : Presses de Sciences Po.

Stiker, H.-J. (1982/2013). *Corps infirmes et sociétés. Essais d'anthropologie historique* (3^e éd.). Paris : Dunod.

Ville, I., Fillion, E., & Ravaud, J.-F. (2014/2020). *Introduction à la sociologie du handicap. Histoire, politiques et expérience* (2^e éd.). Louvain-la-Neuve : De Boeck.

Compléments :

- Blanc, A. (2012). *Sociologie du handicap*. Paris : Armand Colin.
- Buton, F. (2007). Les corps saisis par l'État. *Revue française de science politique*, 57(3-4), 333-360.
- Calvez, M. (2000). La sociologie du handicap. *Sciences sociales et santé*, 18(4), 105-119.

Travail attendu pour la séance 2

Identifier dans votre lieu de FP (actuel ou récent) **un dispositif** qui illustre l'un des paradigmes vus en séance. Préparer 5 lignes d'analyse pour le partager en début de séance 2.

SÉANCE 2 — MODÈLE SOCIAL ET DISABILITY STUDIES

Objectifs

À l'issue de la séance, l'étudiant-e sera capable de :

1. Distinguer **impairment** et **disability** et en mesurer la portée politique
2. Identifier la **rupture conceptuelle** opérée par UPIAS 1976 et Oliver 1990
3. Mobiliser les **critiques internes** du modèle social (féministes, *crip*, postcoloniales)
4. Reconnaître les conséquences pour la **posture professionnelle**

Plan minuté (2 h)

Temps	Contenu	Activité
0-15 min	Restitution des analyses de FP (séance 1)	Tour de table
15-40 min	UPIAS 1976 et la rupture conceptuelle : <i>impairment</i> / <i>disability</i>	Exposé
40-55 min	Oliver 1990 et la politisation du handicap	Exposé
55-75 min	Critiques internes : Crow, French, Shakespeare — féminisme et corps	Exposé
75-110 min	Jigsaw : trois textes / trois sous-groupes	Travail collectif
110-120 min	Synthèse : le modèle social fait-il encore sens en 2026 ?	Discussion

Cadre théorique

La rupture UPIAS 1976

L'Union of the Physically Impaired Against Segregation (Royaume-Uni, 1976) opère une rupture conceptuelle : le handicap n'est pas dans le corps mais dans l'organisation sociale qui exclut les corps « imparés ».

« *Disability is something imposed on top of our impairments by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society.* » (UPIAS 1976)

Trois opérations conceptuelles :

Avant	Après
Handicap = déficience individuelle	Handicap = barrière sociale
Intervention sur la personne	Intervention sur l'environnement
Personne objet de soins	Personne sujet politique

Michael Oliver et la politisation

Michael Oliver (*The Politics of Disablement*, 1990) systématise et politise le modèle social britannique. Il l'inscrit dans une analyse marxiste : le handicap est produit par le **capitalisme industriel** qui exclut les corps non-productifs.

Critiques internes

Liz Crow (1996), Sally French (1993) : le modèle social refuse de prendre au sérieux la souffrance corporelle et l'expérience subjective de la déficience. Une féministe handicapée ne peut pas dire que sa douleur est seulement « sociale ».

Tom Shakespeare (2014, *Disability Rights and Wrongs Revisited*) : le binarisme *impairment/disability* rejoue un dualisme corps/société problématique. Pour Shakespeare, *impairment* et *disability* sont co-construits.

Dan Goodley (2017, *Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction*) : appel à intégrer les intersections de genre, classe, racisation, sexualité dans les *critical disability studies*.

Conséquences pour la posture professionnelle

Le TS comme **acteur du changement environnemental**. Il agit moins sur la personne que sur les barrières — barrières architecturales (rampes, ascenseurs), communicationnelles (FALC, LSF), attitudinales (formation des collègues), organisationnelles (procédures, règlements).

Lectures préparatoires (jigsaw)

Groupe A — Le texte fondateur

UPIAS (1976). *Fundamental Principles of Disability*. Londres. (extraits, 12 pages, en français)

Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Macmillan. **Chapitre 1** (20 pages, version traduite distribuée).

Questions :

- Quelle définition du handicap propose UPIAS ?
- Qu'apporte la systématisation théorique d'Oliver ?
- Pourquoi cette rupture conceptuelle a-t-elle eu autant d'influence ?

Groupe B — Les critiques féministes

Crow, L. (1996). Including all of our lives. *Exploring the Divide*. Leeds : Disability Press, 55-72.

Shakespeare, T. (2014). *Disability Rights and Wrongs Revisited*. Routledge. **Chapitre 2** (« What is disability ? », 25 pages).

Questions :

- Pourquoi Crow critique-t-elle le modèle social ?
- Comment Shakespeare propose-t-il de dépasser le binarisme ?
- Que reste-t-il du modèle social après ces critiques ?

Groupe C — Les *critical disability studies*

Goodley, D. (2017). *Disability Studies* (2^e éd.). Sage. **Chapitre 1** (« Disability Studies », 25 pages).

Questions :

- Qu'est-ce que les *critical disability studies* ?
- Comment articulent-elles handicap, race, genre, classe ?
- Quels exemples contemporains ?

Bibliographie complète de la séance

Crow, L. (1996). Including all of our lives : Renewing the social model of disability. In C. Barnes & G. Mercer (Eds.), *Exploring the Divide*. Leeds : The Disability Press.

French, S. (1993). Disability, impairment or something in between ? In J. Swain et al. (Eds.), *Disabling Barriers — Enabling Environments*. Londres : Sage.

- Goodley, D. (2017). *Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction* (2^e éd.). Londres : Sage.
- Masson, D. (2013). Femmes et handicap. *Recherches féministes*, 26(1), 111-129.
- McRuer, R. (2006). *Crip Theory. Cultural Signs of Queerness and Disability*. New York : NYU Press.
- Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Basingstoke : Macmillan.
- Shakespeare, T. (2014). *Disability Rights and Wrongs Revisited* (2^e éd.). Londres : Routledge.
- UPIAS (1976). *Fundamental Principles of Disability*. Londres : Union of the Physically Impaired Against Segregation.
- Winance, M. (2007). Being normally different ? *Disability & Society*, 22(6), 625-638.

Travail attendu pour la séance 3

Choisir un **règlement institutionnel** (foyer, école, service social) accessible. Identifier les éléments relevant d'une **logique d'accessibilité environnementale** versus ceux relevant d'une **logique de transformation individuelle**.

SÉANCE 3 – MODÈLES FRANCOPHONES : MDH-PPH ET CAPABILITÉS

Objectifs

À l'issue de la séance, l'étudiant-e sera capable de :

1. Mobiliser le **MDH-PPH** pour analyser une situation concrète (facteurs personnels, environnementaux, habitudes de vie)
2. Identifier les **dix capacités centrales** de Nussbaum et leur portée évaluative
3. Articuler le cadre normatif **CDPH ONU 2006** avec les pratiques quotidiennes du TS
4. Appliquer les **quatre modèles** à la vignette de Léa

Plan minuté (2 h)

Temps	Contenu	Activité
0-10 min	Restitution des règlements analysés	Tour de table
10-35 min	MDH-PPH : Fougeyrollas, RIPPH, la métaphore du funambule	Exposé
35-60 min	Capabilités : Sen, Nussbaum, les dix capacités centrales	Exposé
60-80 min	CDPH ONU 2006 : articles 12, 19, 24 ; ratification suisse 2014	Exposé
80-110 min	Application à la vignette de Léa : les 4 modèles en action	Travail collectif
110-120 min	Synthèse	Discussion

Cadre théorique

Le MDH-PPH : un modèle interactif francophone

Patrick Fougeyrollas (*La funambule, le fil et la toile*, 2010) développe au Québec le **Modèle de Développement Humain – Processus de Production du Handicap**, en collaboration avec le RIPPH (Réseau international du processus de production du handicap).

« Le handicap n'est pas une caractéristique de la personne mais le résultat contextuel d'une interaction.
» (Fougeyrollas 2010)

Trois éléments interagissent :

- **Facteurs personnels** : systèmes organiques, aptitudes, facteurs identitaires (le funambule)
- **Habitudes de vie** : activités courantes ou rôles sociaux valorisés (le fil)
- **Facteurs environnementaux** : politiques, aménagements, attitudes, technologies, famille (la toile)

Une **situation de handicap** survient quand la qualité de la toile ne soutient pas le passage du funambule sur le fil. Inversement, une **situation de participation sociale** survient quand la toile soutient.

L'outil opérationnel : la **MHAVIE** (Mesure des habitudes de vie). Diffusion romande : Manon Masse et son équipe HETS (*Accessibilité et participation sociale*, 2018) ont mobilisé ce modèle pour analyser 47 institutions romandes et environ 7 000 adultes avec déficience intellectuelle.

L'approche par les capacités

Amartya Sen (*Development as Freedom*, 1999) propose une alternative aux théories de la justice fondées sur la distribution des ressources (Rawls). Ce qui compte n'est pas ce que la personne possède, mais ce qu'elle peut effectivement **faire et être** — sa **capabilité** réelle.

Martha Nussbaum (*Frontiers of Justice*, 2006) systématise pour les personnes handicapées. Elle propose **dix capacités centrales** comme conditions d'une vie digne :

1. Vie
2. Santé corporelle
3. Intégrité corporelle
4. Sens, imagination, pensée
5. Émotions
6. Raison pratique
7. **Affiliation**
8. Autres espèces
9. **Jeu**
10. **Contrôle de son environnement** (politique et matériel)

Pour le TS : un outil d'évaluation qui dépasse la logique des « besoins » pour interroger les **capabilités à soutenir**.

CDPH ONU 2006 : le tournant des droits

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) consacre le passage d'une approche de protection (*charity, welfare*) à une approche de droits (*rights-based*). Ratifiée par la Suisse le **15 avril 2014**, en vigueur 15 mai 2014.

Trois articles structurants :

Article	Objet	Portée pour le TS
Art. 12	Capacité juridique universelle	Passage de la substitution au soutien à la décision
Art. 19	Vie autonome dans la communauté	Cadre de la désinstitutionnalisation
Art. 24	Éducation inclusive	Cadre de l'école inclusive et de la formation pro

Préambule, considérant (e) :

« Reconnassent que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. »

Application : la vignette de Léa

Léa, 22 ans, trisomie 21, à L'Atelier de la Fondation Ensemble à Genève, demande : « *Je veux un appartement à moi et un amoureux qui dort là.* » Sa mère demande à l'équipe de la « *raisonner* ».

Modèle	Lecture de la situation	Action suggérée
Médical	Diagnostic à évaluer, demande à « raisonner »	Bilan cognitif et fonctionnel
Social	Cadre institutionnel inadapté à l'habitat individuel	Transformer les dispositifs disponibles
MDH-PPH	Habitudes de vie compromises par l'environnement	Cartographier obstacles/facilitateurs
Droits + capacités	Capacités d'affiliation et de contrôle à soutenir	Mobiliser CDPH art. 12, 19, 22 et la contribution d'assistance

Lectures préparatoires (jigsaw)

Groupe A — MDH-PPH

Fougeyrollas, P. (2010). *La funambule, le fil et la toile*. PUL. **Chapitres 2 et 4** (40 pages).

Masse, M. et al. (2018). *Accessibilité et participation sociale*. Éditions ies. **Introduction et chapitre 1** (30 pages).

Groupe B — Capacités

Nussbaum, M. (2006). *Frontiers of Justice*. Belknap/Harvard. **Introduction et chapitre 2** (45 pages, version française).

Bonvin, J.-M. & Farvaque, N. (2008). *Amartya Sen. Une politique de la liberté*. Michalon. **Chapitres 1 et 4** (30 pages).

Groupe C — CDPH

ONU (2006). *CDPH. Préambule, articles 1, 3, 9, 12, 19, 24* (15 pages).

Comité ONU CDPH (2022). *Observations finales sur la Suisse*. CRPD/C/CHE/CO/1. **§ 1-25** (10 pages).

Bibliographie complète de la séance

Bonvin, J.-M., & Farvaque, N. (2008). *Amartya Sen. Une politique de la liberté*. Paris : Michalon.

Comité ONU CDPH (2014). *Observation générale n° 1. Article 12*. CRPD/C/GC/1.

Comité ONU CDPH (2022). *Observations finales concernant le rapport initial de la Suisse*. CRPD/C/CHE/CO/1.

Fougeyrollas, P. (2010). *La funambule, le fil et la toile. Modèles conceptuels appliqués au handicap*. Québec : PUL.

Masse, M., Petitpierre, G., Delessert, Y., Jacquemettaz, M., & Wolf, J.-P. (2018). *Accessibilité et participation sociale*. Genève : Éditions ies.

Mitra, S. (2006). The capability approach and disability. *Journal of Disability Policy Studies*, 16(4), 236-247.

Nussbaum, M. (2006). *Frontiers of Justice*. Cambridge (MA) : Belknap/Harvard.

ONU (2006). *Convention relative aux droits des personnes handicapées*. New York.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford : Oxford University Press.

Travail attendu pour la séance 4

Première entrée du carnet de bord (1 page) : appliquer le MDH-PPH ou les dix capacités à votre cas-fil de FP.

SÉANCE 4 – DÉSINSTITUTIONNALISATION

Objectifs

À l'issue de la séance, l'étudiant-e sera capable de :

1. Comprendre le concept de **désinstitutionnalisation** et ses présupposés
2. Identifier la position **IASSIDD** (Mansell-Beadle-Brown) sur les conditions de qualité
3. Cartographier les **jalons suisses 2014-2026** (CDPH, ONU 2022, plan cantonal, LED-H, Initiative *Pour l'inclusion*)
4. Reconnaître les risques de **transinstitutionnalisation** et de non-recours aggravé

Plan minuté (2 h)

Temps	Contenu	Activité
0-10 min	Retour sur les carnets de bord (1-2 partages)	Tour de table
10-30 min	Article 19 CDPH et observations ONU 2022 sur la Suisse	Exposé
30-50 min	Mansell-Beadle-Brown (2010) : la qualité ne dépend pas de la taille	Exposé
50-70 min	Jalons suisses 2014-2026 : plan cantonal genevois 2023, LED-H 2024, Initiative <i>Pour l'inclusion</i>	Exposé + frise
70-100 min	Jigsaw : 3 textes / 3 sous-groupes	Travail collectif
100-115 min	Étude de cas : Sureaux (Codha + Ensemble) vs foyer EPI	Discussion
115-120 min	Synthèse	Discussion

Cadre théorique

L'article 19 CDPH et son interprétation

L'article 19 pose le droit de « *vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes* ». Il implique trois éléments :

1. **Choix du lieu de vie** et des personnes avec qui vivre
2. **Accès à des services d'assistance personnelle**
3. **Accès aux services généraux** sur la base de l'égalité

Le Comité ONU CDPH (Observation générale n° 5, 2017) interprète strictement : la désinstitutionnalisation suppose la fermeture des établissements résidentiels et leur remplacement par des services communautaires individualisés.

Les observations finales sur la Suisse 2022

Le Comité ONU CDPH a examiné le rapport initial de la Suisse les 14-15 mars 2022 et publié ses observations le 13 avril 2022.

§ 41 : « *The Committee is concerned about the lack of a comprehensive deinstitutionalization strategy.* »

§ 42 : « *Adopt a deinstitutionalization strategy with a clear time frame.* »

80+ recommandations au total. Inclusion Handicap a publié dans la foulée un communiqué « *La Suisse en mauvaise position* ».

Mansell-Beadle-Brown : la qualité ne dépend pas de la taille

Jim Mansell et Julie Beadle-Brown (*Journal of Intellectual Disability Research*, 2010) formulent la position officielle IASSIDD :

« *Community-based services are typically associated with better outcomes than institutional provision, but outcomes vary widely depending on how services are organised.* » (p. 106)

Implications :

- La désinstitutionnalisation **n'est pas** la simple fermeture d'établissements
- Elle suppose un **investissement substantiel** dans les services de proximité
- Sans cet investissement, elle produit de la **transinstitutionnalisation** (déplacement vers d'autres formes de ségrégation) ou aggrave le **non-recours**

Le cas suisse 2014-2026

Année	Évènement
2014	Ratification CDPH par la Suisse (15 avril)
2022	Observations finales du Comité ONU CDPH (80+ recommandations)
2023	Plan cantonal genevois CDPH, volume 1 (janvier)
2024	Avant-projet LED-H en consultation (12 juin)
2024	Initiative populaire fédérale <i>Pour l'inclusion</i> — 107 910 signatures (5 septembre)
2026	Contre-projet du Conseil fédéral, message du 25 février

Étude de cas : Sureaux vs foyer EPI

Sureaux (Chêne-Bougeries) : habitat coopératif inclusif. Partenariat Codha + Fondation Ensemble. 19 logements dont 3 réservés à Ensemble (~12 résidents avec DI). Chantier 2018, emménagement mars 2021. 1^{er} prix Coopératives Habitat Suisse, catégorie « partenariat ». Cas d'école romand d'habitat inclusif.

EPI — Établissements publics pour l'intégration : > 2 000 personnes/an, > 40 lieux, structure historique d'accueil.

Question : comment articuler ces deux modalités dans une stratégie cantonale de désinstitutionnalisation ?

Lectures préparatoires (jigsaw)

Groupe A — Le cadre normatif

Comité ONU CDPH (2017). *Observation générale n° 5 sur l'article 19* (à lire en français, 20 pages).

Comité ONU CDPH (2022). *Observations finales sur la Suisse*. CRPD/C/CHE/CO/1. **Sections sur l'article 19** (10 pages).

Groupe B — La controverse scientifique

Mansell, J., & Beadle-Brown, J. (2010). Deinstitutionalisation and community living. *JIDR*, 54(2), 104-112. (9 pages)

Bigby, C., & Beadle-Brown, J. (2018). Improving quality of life outcomes in supported accommodation. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 31(2), 182-200. (extraits, 15 pages)

Groupe C — Le terrain suisse

AGILE.CH (2023-2024). Dossier *Vie autodéterminée* (20 pages).

Inclusion Handicap (2022). *La Suisse en mauvaise position*. Communiqué + analyse (15 pages).

État de Genève, DCS (2023). *Plan d'action cantonal de mise en œuvre de la CDPH. Volume 1. Synthèse et chapitre sur l'habitat* (25 pages).

Bibliographie complète de la séance

AGILE.CH (2023-2024). *Vie autodéterminée*. Berne : AGILE.CH.

Bigby, C., & Beadle-Brown, J. (2018). Improving quality of life outcomes in supported accommodation for people with intellectual disability. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 31(2), 182-200.

Comité ONU CDPH (2017). *Observation générale n° 5 sur l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société*. CRPD/C/GC/5.

Comité ONU CDPH (2022). *Observations finales concernant le rapport initial de la Suisse*. CRPD/C/CHE/CO/1.

ENIL (2023). *Report on the use of European Structural and Investment Funds*. Bruxelles.

État de Genève, DCS (2023). *Plan d'action cantonal de mise en œuvre de la CDPH. Volume 1*. Genève.

État de Genève, DCS (2024). *Avant-projet de Loi sur l'égalité et les droits des personnes handicapées (LED-H)*. Genève.

Inclusion Handicap (2022). *La Suisse en mauvaise position*. Berne.

Mansell, J., & Beadle-Brown, J. (2010). Deinstitutionalisation and community living. *Journal of Intellectual Disability Research*, 54(2), 104-112.

Power, A. (2013). Making space for belonging : Critical reflections on the implementation of personalised adult social care. *Social Science & Medicine*, 88, 68-75.

Travail attendu pour la séance 5

Identifier un dispositif d'habitat ou d'accompagnement de votre canton de FP. Analyser en 1 page : relève-t-il d'une logique institutionnelle, communautaire, ou intermédiaire ? Quels indicateurs de qualité au sens de Mansell-Beadle-Brown ?

SÉANCE 5 — AUTODÉTERMINATION ET PAIR-AIDANCE

Objectifs

À l'issue de la séance, l'étudiant-e sera capable de :

1. Distinguer **autodétermination** comme trait individuel et comme produit relationnel
2. Mobiliser le **modèle de Wehmeyer** (autonomie, autorégulation, *empowerment*, autoréalisation)
3. Identifier les **conditions d'une pair-aidance non extractive**
4. Adopter une **vigilance épistémique** sur la division témoin/expert

Plan minuté (2 h)

Temps	Contenu	Activité
0-10 min	Retour sur l'analyse de dispositif	Tour de table
10-30 min	Ryan-Deci (2017) : trois besoins psychologiques universels	Exposé
30-50 min	Wehmeyer 1996, Lachapelle 2022 : modèle de l'autodétermination	Exposé
50-70 min	Pair-aidance et savoirs expérientiels : Jouet-Flora-Las Vergnas, HAS, Souesme	Exposé
70-95 min	Vigilance épistémique : la division témoin/expert (Brasseur-Rodriguez 2019)	Exposé + discussion
95-115 min	Étude de cas : intégrer un-e pair-aidant-e dans un service social	Travail collectif
115-120 min	Synthèse	Discussion

Cadre théorique

Ryan et Deci : trois besoins universels

Richard Ryan et Edward Deci (*Self-Determination Theory*, 2017) identifient trois besoins psychologiques fondamentaux **universels** :

Besoin	Définition	Question test
Autonomie	Agir en accord avec ses valeurs	La personne agit-elle selon ce qu'elle ressent juste ?
Compétence	Éprouver son efficacité	La personne peut-elle voir l'effet de ses actions ?
Appartenance	Être relié-e à autrui	La personne se sent-elle reconnue dans un collectif ?

« *Autonomy, competence, and relatedness are not just preferences but universal psychological necessities.* » (p. 86)

L'enjeu opérationnel : distinguer **contrôler**, **contraindre**, **soutenir l'autonomie** (*autonomy support*).

Wehmeyer et l'agentivité causale

Michael Wehmeyer (1996) propose une opérationnalisation centrée sur le concept d'**agent causal** : agir comme le principal agent causal de sa propre vie.

Quatre caractéristiques :

1. **Autonomie comportementale**
2. **Autorégulation**
3. **Empowerment** psychologique
4. **Autoréalisation**

Lachapelle, Wehmeyer et Shogren (*La Nouvelle Revue – Éducation et société inclusives*, 2022) prolongent avec la *Causal Agency Theory* : l'autodétermination n'est pas un trait individuel à entraîner mais un produit relationnel et écosystémique.

La pair-aidance : cartographie et controverses

Jouet, Flora et Las Vergnas (2010) cartographient pour la francophonie la production de savoirs spécifiques par les personnes concernées :

« Les patients développent, au fil de l'expérience de la maladie, des savoirs spécifiques qui ne sont pas réductibles aux savoirs médicaux. »

À Genève, les recherches HETS de Manon Masse, Chloé Souesme et Yves Delessert documentent la pair-aidance dans le champ DI. Souesme (REISO, 2024) propose une analyse opérationnelle : « Des pair-e-s pour faciliter l'habitat autonome. »

La HAS (2022) a inscrit la pair-aidance dans ses recommandations de bonnes pratiques pour le secteur DI.

Vigilance épistémique : la division témoin / expert

Brasseur et Rodriguez (*Participations*, 2019) montrent que malgré la rhétorique participative, une division du travail épistémique persiste :

« Les personnes handicapées sont invitées à témoigner de leur expérience pendant que les valides en produisent l'analyse. La participation se déploie selon une économie inégale de la parole. »

Quatre conditions pour une pair-aidance non extractive :

1. **Co-construction structurelle** dès la conception
2. **Pluralité représentée** (déficiences, classes, genres, âges)
3. **Rétribution et formation** au niveau des autres experts
4. **Transparence sur les rapports de pouvoir** entre valides et concernés

Lectures préparatoires (jigsaw)

Groupe A – Théorie de l'autodétermination

Ryan, R. & Deci, E. (2017). *Self-Determination Theory*. Guilford. **Chapitres 1 et 5** (40 pages, traduction d'extraits).

Wehmeyer, M. (1996). Self-determination as an educational outcome. In Sands & Wehmeyer (Eds.), *Self-determination across the life span*. Brookes. (20 pages)

Groupe B – Pair-aidance et savoirs expérientiels

Jouet, E., Flora, L., & Las Vergnas, O. (2010). *Pratiques de formation – Analyses*, 58-59. (25 pages)

Souesme, C. (2024). Des pair-e-s pour faciliter l'habitat autonome. *REISO*. (15 pages)

HAS (2022). *Autodétermination, participation et citoyenneté*. TDI Volet 1. **Synthèse** (15 pages).

Groupe C – Vigilance épistémique

Brasseur, P., & Rodriguez, J. (2019). Les handicapés témoins, les valides experts. *Participations*, 22(3), 139-158. (20 pages)

Charlton, J. (1998). *Nothing About Us Without Us*. UC Press. **Introduction et chapitre 1** (35 pages, traduction).

Bibliographie complète de la séance

Brasseur, P., & Rodriguez, J. (2019). Les handicapés témoins, les valides experts. *Participations*, 22(3), 139-158.

Charlton, J. I. (1998). *Nothing About Us Without Us. Disability Oppression and Empowerment*. Berkeley : University of California Press.

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The « what » and « why » of goal pursuits. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
- HAS (2022). *Autodétermination, participation et citoyenneté*. TDI Volet 1. Paris.
- Jouet, E., Flora, L., & Las Vergnas, O. (2010). Construction et reconnaissance des savoirs expérimentiels des patients. *Pratiques de formation – Analyses*, 58-59.
- Lachapelle, Y., Wehmeyer, M., & Shogren, K. (2022). *La Nouvelle Revue – Éducation et société inclusives*, 94(2).
- Pachoud, B., & Corbière, M. (2014). Pratiques et interventions de soutien à l'insertion professionnelle des personnes ayant un trouble psychique. *L'Évolution psychiatrique*, 79(3), 365-381.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-Determination Theory. Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. New York : Guilford.
- Shogren, K. A., Wehmeyer, M. L., et al. (2015). Causal Agency Theory. *Education and Training in Autism and Developmental Disabilities*, 50(3), 251-263.
- Souesme, C. (2024). Des pair-e-s pour faciliter l'habitat autonome. *REISO*.
- Wehmeyer, M. (1996). Self-determination as an educational outcome.

Travail attendu pour la séance 6

Identifier dans votre lieu de FP **un dispositif** mobilisant explicitement l'autodétermination ou la pair-aidance. Évaluer son fonctionnement à l'aune des conditions opérationnelles vues en séance.

SÉANCE 6 — FINANCEMENT ORIENTÉ PERSONNE

Objectifs

À l'issue de la séance, l'étudiant-e sera capable de :

1. Comprendre la logique **cash-for-care** et ses ressorts politiques
2. Connaître les **chiffres clés** de la contribution d'assistance AI suisse (OFAS 2020)
3. Mobiliser une **perspective comparée** (France, Angleterre, Pays-Bas)
4. Accompagner concrètement une personne dans la demande de contribution d'assistance

Plan minuté (2 h)

Temps	Contenu	Activité
0-10 min	Retour sur les dispositifs d'autodétermination	Tour de table
10-30 min	Logique cash-for-care (Le Bihan, Da Roit, Sopadzhyan 2019)	Exposé
30-50 min	Contribution d'assistance AI suisse : OFAS 2020, chiffres et critiques	Exposé
50-70 min	Perspective comparée : <i>direct payments</i> anglais (Glendinning 2008)	Exposé
70-100 min	Simulation d'accompagnement : remplir une demande de contribution d'assistance	Travail collectif
100-115 min	Retour à Léa : la contribution est-elle une solution ?	Discussion

Temps	Contenu	Activité
115-120 min	Synthèse	Discussion

Cadre théorique

La logique *cash-for-care*

Le Bihan, Da Roit et Sopadzhayan (*Social Policy & Administration*, 2019) analysent les politiques *cash-for-care* en France, Italie, Pays-Bas comme un « *familialisme optionnel par le marché* ». Les familles continuent à produire l'essentiel de l'aide mais peuvent acheter du soin sur un marché concurrentiel.

Trois conséquences :

1. **Autonomie de choix accrue** pour la personne / la famille
2. **Précarisation des aidant-es professionnel·les**, souvent migrant·es
3. **Inégalités d'accès** selon la capacité à gérer (faire les démarches, recruter, suivre les comptes)

La contribution d'assistance AI suisse

Introduite le **1^{er} janvier 2012** par la 6^e révision LAI. Logique : la personne reçoit l'argent et engage elle-même ses assistant·es comme employeur·euse.

Chiffres OFAS 2020 :

- ~ **2 600 bénéficiaires** fin 2019 (cible initiale 3 000 dès 2012)
- Durée moyenne d'engagement : **41 h/semaine**
- Satisfaction : **81 %** de bénéficiaires satisfaits ou très satisfaits
- Rares retours en home

Critiques structurelles (Inclusion Handicap, AGILE.CH) :

- **Barrières administratives** lourdes (formulaire, calcul des besoins, statut employeur-bénéficiaire)
- **Pénurie d'assistant·es** disponibles
- **Non-extension aux mineurs** et aux personnes en **curatelle de portée générale**

Le cas anglais : *direct payments* et *individual budgets*

Caroline Glendinning (*Social Policy & Administration*, 2008) :

« *Personalisation marks a shift from the citizen-as-recipient to the citizen-as-purchaser of care.* »

Tableau comparé :

Pays	Dispositif	Année	Critique principale
Suisse	Contribution d'assistance AI	2012	Diffusion limitée, complexité admin.
France	PCH	2005	Familialisme par défaut
Angleterre	<i>Direct payments</i> / <i>Individual budgets</i>	1996 / 2003	Inégalités de capacité à gérer
Pays-Bas	Budget personnel (PGB)	1995	Précarisation des care workers

Retour à Léa : la contribution d'assistance est-elle une solution ?

Léa **n'est pas** sous curatelle de portée générale □ elle est **éligible**. Elle aurait à embaucher elle-même ses assistant·es. Mais : sait-elle qu'elle existe ? Sait-elle remplir le formulaire ? Connaît-elle ses droits de recours ?

« Les droits ne sont pas seulement ce que les textes disent, mais ce que les personnes parviennent à en faire. » (Revillard 2020)

Le TS est un **opérateur clé de l'effectivité**. À Genève : Pro Infirmis, Cap-Contact, services sociaux institutionnels.

Lectures préparatoires (jigsaw)

Groupe A — Le contexte suisse

OFAS (2020). *Évaluation finale de la contribution d'assistance AI. Synthèse et chapitres 3-4* (30 pages).

Inclusion Handicap (2022). Position sur la contribution d'assistance. (10 pages)

Groupe B — La perspective comparée

Le Bihan, B., Da Roit, B., & Sopadzhayan, A. (2019). *Social Policy & Administration*, 53(4), 579-595. (17 pages)

Glendinning, C. (2008). *Social Policy & Administration*, 42(5), 451-469. (19 pages)

Groupe C — Le terrain

Fracheboud, V. & Lehmann, C. (2019). L'introduction de la contribution d'assistance en Suisse. *Revue suisse de travail social*, 26, 11-28. (18 pages)

AGILE.CH (2023). *Vie autodéterminée — chapitre assistance personnelle* (15 pages).

Bibliographie complète de la séance

AGILE.CH (2023). *Vie autodéterminée*. Berne.

Da Roit, B., & Le Bihan, B. (2010). Similar and yet so different : Cash-for-care in six European countries' long-term care policies. *The Milbank Quarterly*, 88(3), 286-309.

Fracheboud, V., & Lehmann, C. (2019). L'introduction de la contribution d'assistance en Suisse. *Revue suisse de travail social*, 26, 11-28.

Glendinning, C. (2008). Increasing choice and control. *Social Policy & Administration*, 42(5), 451-469.

Inclusion Handicap (2022). Position sur la contribution d'assistance. Berne.

Le Bihan, B., Da Roit, B., & Sopadzhayan, A. (2019). The turn to optional familism through the market. *Social Policy & Administration*, 53(4), 579-595.

OFAS (2020). *Évaluation finale de la contribution d'assistance AI*. Berne.

Power, A. (2013). Making space for belonging. *Social Science & Medicine*, 88, 68-75.

Travail attendu pour la séance 7

Deuxième entrée du carnet de bord (1 page) : décrire une situation de FP où la mobilisation (ou non-mobilisation) d'un droit a transformé le déroulement de l'accompagnement.

SÉANCE 7 — POSTURE PROFESSIONNELLE : TROIS TENSIONS

Objectifs

À l'issue de la séance, l'étudiant-e sera capable de :

1. Nommer les **trois tensions structurelles** de la posture du TS

2. Mobiliser la **clinique de l'activité** (Clot) et la *street-level bureaucracy* (Lipsky) pour analyser sa pratique
3. Comprendre l'apport de l'**éthique du care** (Tronto, Paperman-Laugier) pour penser la vulnérabilité
4. Reconnaître la dimension de **travail émotionnel** (Hochschild) du métier

Plan minuté (2 h)

Temps	Contenu	Activité
0-10 min	Partage de carnets de bord (2-3 situations)	Tour de table
10-30 min	Tension 1 — Protection / Autonomie : Perske, Tronto	Exposé
30-50 min	Tension 2 — Expertise / Savoir expérientiel : Charlton, Brasseur-Rodriguez	Exposé
50-75 min	Tension 3 — Travail prescrit / Travail réel : Clot, Lipsky, Lenzi-Moine	Exposé
75-95 min	Dimension émotionnelle : Hochschild	Exposé
95-115 min	Travail réflexif : auto-confrontation par binôme sur une situation rapportée	Travail collectif
115-120 min	Synthèse	Discussion

Cadre théorique

Tension 1 — Protection / Autonomie

Robert Perske (1972) formule l'une des phrases les plus citées du champ :

« There can be such a thing as human dignity in risk. And there can be a dehumanizing indignity in safety! »

La **dignité du risque** signifie que les personnes ayant une déficience intellectuelle ont droit à prendre des risques ordinaires. Surprotéger nie l'humanité de la personne.

L'**article 12 CDPH** opère le déplacement juridique : du paradigme tutélaire (substitution de décision) au paradigme du soutien à la décision (*supported decision-making*).

Joan Tronto (2009) déplace le care de l'éthique privée vers la philosophie politique :

« Nous sommes tous des êtres vulnérables et dépendants. Il s'agit de redistribuer la responsabilité du care, non de la concentrer sur les plus faibles. »

Patricia Paperman et Sandra Laugier (2006/2011) introduisent les *care ethics* en francophonie.

Tension 2 — Expertise / Savoir expérientiel

James Charlton (1998) : *« Nothing about us without us. »* Plus qu'un slogan : une **épistémologie politique**.

Brasseur et Rodriguez (2019) : malgré la rhétorique participative, une division du travail épistémique persiste.

« Les personnes handicapées sont invitées à témoigner de leur expérience pendant que les valides en produisent l'analyse. »

Tension 3 — Travail prescrit / Travail réel

Yves Clot (1999, 2008) : la clinique de l'activité.

Distinction centrale :

- **Travail prescrit** : référentiels, procédures, contraintes du financement
- **Activité réalisée** : ce qui est effectivement fait
- **Réel de l'activité** : inclut aussi ce qui n'est pas fait, ce qui aurait pu être fait, ce qui est **empêché**

« Ce qui rend malade au travail, ce n'est pas le conflit, c'est l'impossibilité du conflit. »

Michael Lipsky (1980/2010) : la street-level bureaucracy.

« The decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the devices they invent to cope with uncertainties and work pressures effectively become the public policies they carry out. »

Les TS ne sont pas seulement des exécutant-es : illes sont des **producteur-trices de politique publique au guichet**, exerçant une *autonomie discrétionnaire*.

Vincent Dubois (2010) : ethnographie du guichet, articulation contraintes bureaucratiques / demandes sociales / travail relationnel.

Catherine Lenzi et Alexandre Moine (2025) : Des pas de côté dans le travail social. Les marges du métier comme lieu d'invention professionnelle.

Le travail émotionnel

Arlie Hochschild (1983) :

« This labor requires one to induce or suppress feeling in order to sustain the outward countenance that produces the proper state of mind in others. »

Annoncer un refus AI, accompagner une fin de droits, recadrer un proche : autant de situations où le travail émotionnel est central, **invisible dans les fiches de poste**, coûteux psychologiquement.

Le praticien réflexif

Donald Schön (1983/1994) :

« Les praticiens compétents en savent généralement plus qu'ils ne peuvent en dire. »

Lectures préparatoires (jigsaw)

Groupe A — Care et protection

Tronto, J. (2009). *Un monde vulnérable*. La Découverte. **Chapitres 1 et 4** (40 pages).

Perske, R. (1972). The dignity of risk and the mentally retarded. *Mental Retardation*, 10(1), 24-27. (4 pages)

Groupe B — Clinique de l'activité et street-level bureaucracy

Clot, Y. (2008). *Travail et pouvoir d'agir*. PUF. **Chapitres 1 et 3** (40 pages).

Lipsky, M. (1980/2010). *Street-Level Bureaucracy*. **Chapitres 1, 5, 11** (40 pages, traduction d'extraits).

Groupe C — Marges et travail émotionnel

Lenzi, C., & Moine, A. (2025). *Des pas de côté dans le travail social*. Champ social. **Introduction + 2 chapitres au choix** (40 pages).

Hochschild, A. (1983). *The Managed Heart*. UC Press. **Introduction et chapitre 1** (30 pages, traduction).

Bibliographie complète de la séance

- Brasseur, P., & Rodriguez, J. (2019). Les handicapés témoins, les valides experts. *Participations*, 22(3), 139-158.
- Charlton, J. I. (1998). *Nothing About Us Without Us*. Berkeley : University of California Press.
- Clot, Y. (1999). *La fonction psychologique du travail*. Paris : PUF.
- Clot, Y. (2008). *Travail et pouvoir d'agir*. Paris : PUF.
- Dubois, V. (2010). *La vie au guichet* (3^e éd.). Paris : Économica.
- Fisher, B., & Tronto, J. (1990). Toward a feminist theory of caring. In E. Abel & M. Nelson (Eds.), *Circles of Care*. Albany : SUNY Press.
- Hochschild, A. R. (1983). *The Managed Heart*. Berkeley : University of California Press.
- Lenzi, C., & Moine, A. (2025). *Des pas de côté dans le travail social*. Nîmes : Champ social.
- Lipsky, M. (1980/2010). *Street-Level Bureaucracy*. New York : Russell Sage Foundation.
- Molinier, P. (2013). *Le travail du care*. Paris : La Dispute.
- Paperman, P., & Laugier, S. (Eds.) (2006/2011). *Le souci des autres*. Paris : EHESS.
- Perske, R. (1972). The dignity of risk and the mentally retarded. *Mental Retardation*, 10(1), 24-27.
- Schön, D. A. (1983/1994). *Le praticien réflexif*. Montréal : Éditions Logiques.
- Tronto, J. (2009). *Un monde vulnérable*. Paris : La Découverte.

Travail attendu pour la séance 8

Troisième entrée du carnet de bord (1 page) : auto-confrontation sur une situation où vous avez ressenti une tension (entre les trois identifiées). Quels concepts mobiliseriez-vous pour la penser ?

SÉANCE 8 — APPLICATION ET PERSPECTIVES

Objectifs

À l'issue de la séance, l'étudiant-e sera capable de :

1. Articuler les **acquis du cours** dans une analyse de situation de FP
2. Reconnaître les **intersections** handicap-migration-genre-classe (Piérart, Brasseur)
3. Mobiliser les **questions de sexualité et de violences** (Brasseur 2024, art. 16 et 22 CDPH)
4. Construire une **posture argumentée** pour la suite de sa formation

Plan minuté (2 h)

Temps	Contenu	Activité
0-15 min	Présentations courtes (3-4 étudiant-es) de leur cas-fil de FP	Tour de table
15-35 min	Intersections handicap-migration (Piérart)	Exposé
35-55 min	Sexualité, intimité, violences (Brasseur 2024, R1 acceptée 2026)	Exposé

Temps	Contenu	Activité
55-80 min	Trois controverses contemporaines : désinstitutionnalisation, <i>cash-for-care</i> , participation	Débat structuré
80-105 min	Synthèse collective : quelle posture professionnelle ai-je construite ?	Travail collectif
105-115 min	Présentation du travail final et modalités d'évaluation	Cadrage
115-120 min	Clôture	Discussion

Cadre théorique

Intersections handicap-migration

Geneviève Piérart (HETS Fribourg, *Handicap, famille et migration*, 2013) documente l'intersection : les familles migrantes confrontées au handicap d'un enfant cumulent des obstacles linguistiques, juridiques, culturels. Sous-représentation dans les dispositifs d'aide précoce.

Concepts mobilisés : non-recours, médiation interculturelle, représentations culturelles du handicap.

Sexualité, intimité, violences

Pierre Brasseur (*Sociologie de l'assistance sexuelle*, PUF 2024) enquête sur l'émergence et l'institutionnalisation de l'assistance sexuelle en Europe francophone (Suisse, Belgique, France). Frontière entre travail du care, travail du sexe et politiques du handicap.

Brasseur, Robert et Garré (R1 acceptée 2026, *Social Science & Medicine*) documentent les angles morts institutionnels dans la prise en charge des violences sexuelles subies par les enfants en situation de handicap.

Articulation des droits CDPH :

- **Article 16** — Droit à la protection contre l'exploitation, la violence et la maltraitance
- **Article 22** — Droit au respect de la vie privée

Trois controverses contemporaines

Controverse	Position A	Position B
Désinstitutionnalisation	Horizon réaliste	Risque de transinstitutionnalisation
<i>Cash-for-care</i>	Vecteur d'autodétermination	Familialisme par le marché
Participation	Avancée démocratique	Nouvelle injonction

Synthèse collective

Question structurante : « *Quelle posture professionnelle ai-je construite au fil des 8 séances ?* »

Trois axes pour la réponse :

1. **Mes outils théoriques** : quels modèles je mobilise spontanément ?
2. **Mes vigilances** : quelles asymétries je m'oblige à interroger ?
3. **Mes lieux d'action** : quelles marges je vais mobiliser en FP ?

Lectures préparatoires (jigsaw)

Groupe A — Intersections

Piérart, G. (Ed.) (2013). *Handicap, famille et migration*. IES. **Introduction et 1 chapitre au choix** (40 pages).

Groupe B — Sexualité, assistance sexuelle

Brasseur, P. (2024). *Sociologie de l'assistance sexuelle*. PUF. **Introduction et chapitre 5** (40 pages).

Groupe C — Violences institutionnelles

Brasseur, P., Robert, L., & Garré, B. (R1 acceptée 2026). *Sexual violence against children with disabilities*. *Social Science and Medicine*. **Manuscrit complet, anonymisé** (25 pages).

Bibliographie complète de la séance

Brasseur, P. (2024). *Sociologie de l'assistance sexuelle. Travail du care, travail sexuel et politiques du handicap*. Paris : PUF.

Brasseur, P., & Rodriguez, J. (2019). Les handicapés témoins, les valides experts. *Participations*, 22(3), 139-158.

Brasseur, P., Robert, L., & Garré, B. (R1 acceptée 2026). Sexual violence against children with disabilities. *Social Science and Medicine*.

Lucas, B. (2022). *Care, droits et citoyenneté*. Genève : HETS / PNR 74.

Piérart, G. (Ed.) (2013). *Handicap, famille et migration*. Genève : IES.

Revillard, A. (2017). La réception du droit du handicap. *Droit et société*, 96(2), 269-285.

Stiker, H.-J., Puig, J., & Huet, A. (2014). *Handicap et accompagnement*. Paris : Dunod.

Travail final (rendu 4 semaines après la séance 8)

Format

Document de **12 pages** (5 000-7 000 mots), bibliographie comprise.

Consignes

Analyser une situation rencontrée en formation pratique (ou un dispositif observé). La situation doit être **anonymisée** (sans noms, sans lieu identifiable).

L'analyse doit :

1. **Décrire** la situation et son contexte institutionnel (1 page)
2. **Identifier** au moins 2 modèles du handicap à l'œuvre dans le dispositif (2 pages)
3. **Mobiliser** le cadre normatif suisse pertinent (1,5 page)
4. **Analyser** une tension de posture rencontrée par les professionnel·les (2 pages)
5. **Proposer** une transformation argumentée (2 pages)
6. **Réflexivité** sur votre propre position d'apprentissage (1,5 page)
7. **Bibliographie** d'au moins 8 références du cours mobilisées dans le corps du texte (2 pages)

Critères d'évaluation

Critère	Pondération
Rigueur de la mobilisation théorique	25 %
Précision du cadrage normatif suisse	15 %

Critère	Pondération
Qualité de l'analyse de tension de posture	20 %
Argumentation de la proposition de transformation	20 %
Qualité de la réflexivité sur sa position	10 %
Qualité rédactionnelle et bibliographique	10 %

RESSOURCES TRANSVERSALES

Bibliographie générale (à disposition tout au long du cours)

Les 64 fiches de lecture structurées (Thèse · Concepts · Citations · Exemple BA · Limite) sont mises à disposition des étudiant-es au format PDF. Liste complète des références dans le livre Quarto compagnon : <https://pierrebrasseur.github.io/handicap-autonomie-ts/>.

Ressources institutionnelles genevoises

Administration cantonale : DCS, OAIS, CCI, OAI Genève, imad, SCOPSE.

Faïtières : INSOS Genève, fégaph, Pro Infirmis Genève, Cap-Contact, Inclusion Handicap, AGILE.CH.

Grandes fondations : Fondation Ensemble, Fondation Aigues-Vertes, EPI, Fondation Clair Bois, Fondation Foyer-Handicap.

Projet emblématique : Sureaux (Codha + Fondation Ensemble).

Recherche et formation : HETS Genève — CERES, pôle d'expertise Handicap, réseau Autonomie-Handicap-Dépendance animé par Catherine Lenzi.

Cadre éthique du cours

- Les situations de FP partagées en séance sont **anonymisées** (sans noms, sans lieu identifiable)
- La séance 8 (sexualité, intimité, violences) fait l'objet d'un **cadre spécifique** : possibilité de se retirer ou de demander un entretien individuel
- La **pluralité des positions** est respectée. Les controverses internes au champ sont présentées comme telles
- Lecture critique : **aucune référence n'est présentée comme dogme**

Articulation avec les autres dispositifs HETS

Dispositif	Articulation
Module Bachelor <i>Handicap, autonomie et travail social</i> (13 séances)	Ce cours en est une version condensée et intensive
MAP <i>Inclusion et déficience intellectuelle</i> (Manon Masse)	Ce cours en est une mise en perspective théorique et critique
MAP <i>Violences dans le champ social</i>	La séance 8 prépare à cette MAP
Formation pratique 2 (s5-s6)	Le carnet de bord et le travail final s'articulent à votre FP
Module <i>Politiques sociales suisses</i> (s3, pré-requis)	Ce cours en mobilise les acquis